

每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-06-13 ~ 2026-06-20

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋期刊：NEJM | Lancet | EHJ | JACC 系列 | Circulation 系列 | EuroIntervention

  每篇 Pick / 文章附 QR Code，可掃描跳轉原文

本期已與上一期（2026-06-19）交叉去重，全為新刊出或未收錄之文獻。

本週主題與固定欄目

精準化 × 可近性的雙軸

本週六大固定欄目：

1.  **Top 5 Picks** — 跨期刊精選
2.  **TAVI Section** — 本週 TAVI 重要文獻
3.  **TEER Section** — PASCAL / MitraClip / TriClip 進展
4.  **Honorable Mentions** — 其他值得讀
5.  **Case Reports** — JACC Case Rep / EuroIntervention × 5
6.  **參考文獻 + 縮寫對照**

Top 5 Picks

試驗／研究	期刊	關鍵數字
Elecglipton (VISTA/SOLSTICE)	<i>Lancet</i>	體重 -11.8% (36 週) ; HbA1c -1.88%
Black Americans CV 死亡率	<i>JACC</i>	進度報告：種族落差持續 (2000–2024)
AI-ECG 偵測 HCM	<i>JACC Adv</i>	AUC 0.946 ; 特異度 100% ; 提前 2.6 年
CKM 危險因子治療	<i>JACC</i>	高血壓／高血脂僅約 50% 接受治療
Genome-First FH 族群差異	<i>Circulation</i>	非洲血統 VUS → MI OR 1.91

Pick #1

Elecglipton (VISTA + SOLSTICE)

口服小分子 GLP-1 受體促效劑

Elecoglipron — 設計

Davies MJ, et al. (VISTA) / Aroda VR, et al. (SOLSTICE)

 VISTA DOI: 10.1016/S0140-6736(26)00748-8

- 每日一次口服小分子 GLP-1 受體促效劑 (GLP-1 Receptor Agonist, GLP-1 RA) , 無飲食／飲水限制
- **VISTA** : 肥胖／過重、無糖尿病, Phase 2 劑量探索 RCT, n=**310**, 36 週
- **SOLSTICE** : 第二型糖尿病 (Type 2 Diabetes, T2D), Phase 2b RCT, n=**404** (oral semaglutide 對照)



 Scan DOI

-10.5% → -11.8%

VISTA 體重變化 (26 → 36 週, 75 mg)

vs placebo -0.6% / -0.3% ; 尚未進入平台

SOLSTICE : HbA1c -1.88% (75 mg) vs placebo -0.15%

Elecglipton — 臨床啟示

 口服小分子 GLP-1 RA（非胜肽、無飲食限制）若 Phase 3 重現此效力，將大幅改善代謝治療的**可近性與順從性**。

- 已宣布進入 **Phase 3**，含**心血管與腎臟結局試驗**
- 對台灣龐大 T2D／肥胖共病心血管族群具高度潛在意義
- 仍須等待 head-to-head 與長期心血管硬終點數據

Pick #2

Excess CV Mortality

Black Americans, 2000–2024 (JACC 進度報告)

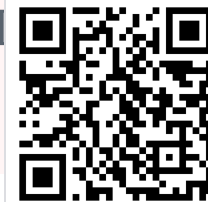
Black Americans CV 死亡率 — JACC 進度報告

Arun AS, Yancy CW, Krumholz HM, et al.

 DOI: [10.1016/j.jacc.2026.05.013](https://doi.org/10.1016/j.jacc.2026.05.013) | PMID: 42319310

- 回顧 2000–2024 年美國黑人 vs 白人族群的**心血管超額死亡**與**壽命年損失**
- 經二十餘年努力，種族落差**仍持續存在**
- 強調結構性與社會決定因素的長期影響

 證據不足以消弭不平等 — 需政策與照護路徑改革。台灣應警覺城鄉與社經落差對心血管照護的影響。



 Scan DOI

Pick #3

AI-ECG 偵測 HCM

Viz HCM 演算法外部驗證

AI-ECG 偵測 HCM — 設計與結果

Park J, et al. *JACC Adv* 2026;5(7):102914.

 DOI: [10.1016/j.jacadv.2026.102914](https://doi.org/10.1016/j.jacadv.2026.102914)

- 150 例心臟磁共振造影 (Cardiac MRI) 確診肥厚型心肌病 (Hypertrophic Cardiomyopathy, HCM) + 83 對照
- Viz HCM 12 導程心電圖 (Electrocardiogram, ECG) 演算法

指標	數值
AUC	0.946 (0.916–0.970)
敏感度 / 特異度	58% / 100%
提前診斷	中位 2.6 年

心尖型 (apical) HCM 為正確偵測預測因子 (OR 4.71)



 Scan DOI

AI-ECG 偵測 HCM — 臨床啟示

 高特異度（100%）+ 可提前偵測 → 適合作為**機會性篩檢 (opportunistic screening)** 的「rule-in」工具。

- 敏感度 58% → **不可**作為排除工具
- 心尖型 HCM 偵測力最佳
- 可整合於健檢／門診 ECG 流程，及早轉介影像確診

Pick #4

CKM Syndrome

心血管代謝危險因子治療現況

CKM 危險因子治療 — NHANES

Gong J, Wadhera RK, et al. *J Am Coll Cardiol* 2026 Jun 17.

 [DOI: 10.1016/j.jacc.2026.04.031](https://doi.org/10.1016/j.jacc.2026.04.031)

- NHANES 2015–2023 , n=**6,384** , Cardiovascular-Kidney-Metabolic (CKM) syndrome $\geq$ stage 2

危險因子	治療率	治療者控制率
高血壓	51.3%	44.7%
高血脂	48.8%	68.2%
糖尿病	83.4%	47.3%

缺口最大：**20–44 歲年輕成人**、女性、西班牙裔



 Scan DOI

CKM 危險因子治療 — 臨床啟示



真實世界中**僅約半數**接受高血壓／高血脂治療，且控制不足。

- 年輕族群、女性是被忽視的高風險群
- 勿因「年輕」低估心血管代謝風險
- 及早起始 guideline-directed 治療

Pick #5

Genome-First FH

非洲 vs 歐洲血統的差異

Genome-First FH — 族群差異

Winters AH, Gidding SS, et al. *Circulation* 2026;153(24):1928–1939.

 DOI: [10.1161/CIRCULATIONAHA.126.080694](https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.126.080694)

- Genome-first , n=**104,300** 非洲血統 (All of Us / BioMe / MyCode)
- 致病變異盛行率：非洲 1:306 vs 歐洲 1:273 (**相當**)
- 非洲血統致病變異者 LDL-C 多升高 **20.81 mg/dL**
- **意義未明變異 (Variant of Unknown Significance, VUS)**：非洲血統機率高 1. 倍，且 VUS → **MI OR 1.91** (歐洲血統無此關聯)



 Scan DOI

Genome-First FH — 臨床啟示

 現行變異分類資源以歐洲族群為主 → 可能造成**非洲血統家族性高膽固醇血症 (FH)** 的低診斷。

- 對台灣／東亞：本土變異庫同樣不足，VUS 判讀須謹慎
- 不宜輕易視 VUS 為「良性」
- 推動本土基因資料庫是精準血脂醫療的關鍵



TAVI Section

本週 TAVI 相關文獻

Drake 主要臨床方向

TAVI #1 — 慢性發炎性疾病患者的 TAVR

Verma BR, Waksman R, et al. *Am J Cardiol* 2026 Jun 18.

 DOI: [10.1016/j.amjcard.2026.06.010](https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2026.06.010)

- 單中心，n=**2,880**；慢性發炎性全身疾病 (Chronic Inflammatory systemic Diseases, CIDs) 佔 6.4%
- 住院死亡 (0.0% vs 1.7%)、1 年死亡 (8.9% vs 8.91%) **無差異**
- **血管併發症較多**：10.3% vs 6.1% (p=0.036)；非計畫性血管介入 5.4% vs 1.9% (p=0.003)

 CIDs 病人 TAVR 安全，但**血管入路併發症**↑ → 加強術前血管評估與入路規劃



 Scan DOI

TAVI #2 — 術前冠狀動脈 CTA vs ICA

Kaya M, et al. *J Med Imaging Radiat Oncol* 2026 Jun 16.

 DOI: [10.1111/1754-9485.70134](https://doi.org/10.1111/1754-9485.70134)

- n=**95** , TAVI 前同時做冠狀動脈 CT 血管攝影 (CTA) 與侵入性冠狀動脈攝影 (ICA)
- 70% 狹窄切點：CTA 與 ICA **高度一致**，敏感／特異度佳
- 阻塞性冠狀動脈疾病 (CAD) 盛行率 82.1%
- 1 年存活 93.7%，**與 CAD 存在與否無關** (p=0.466)

 術前 CTA 可作為冠狀動脈評估的**實用非侵入選項**，有機會減少不必要的 ICA



 Scan DOI

TAVI #3 — 乳頭肌位置與 TAVR 後 MR

Li X, Chen M, et al. *Catheter Cardiovasc Interv* 2026 Jun 16.

 DOI: [10.1002/ccd.70703](https://doi.org/10.1002/ccd.70703)

- 1,159 例 TAVR 中，125 例術前二尖瓣逆流 (Mitral Regurgitation, MR) $\geq 3+$
- 以多排電腦斷層 (MSCT) 分析乳頭肌 (Papillary Muscle, PM) 幾何
- **PM 下移 (inferior displacement)** 為 MR 不改善的獨立預測因子 (OR **5.629** , $p=0.014$)

 術前評估乳頭肌幾何可預測 TAVR 後 MR 是否改善 → 協助規劃是否需後續二尖瓣介



 Scan DOI



TEER Section

PASCAL × MitraClip × TriClip

Drake 的 TEER 操作面向

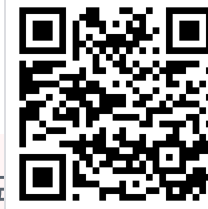
TEER #1 — PASCAL Precision vs MitraClip G4

Enta Y, Hayashida K, et al. *Catheter Cardiovasc Interv* 2026 Jun 17.

 DOI: [10.1002/ccd.70702](https://doi.org/10.1002/ccd.70702)

- 日本 OCEAN-Mitral 登記，原發性 MR (PMR) : PASCAL **n=150** vs MitraClip G4 **n=679** (傾向分數配對)
- 30 天 MR $\leq 2+$ (92.3% vs 92.1%)、MR $\leq 1+$ (71.6% vs 65.8%)、裝置成功 (95.0% vs 92.1%) **均無顯著差異**
- PASCAL : 1 例單葉裝置附著 (Single Leaflet Device Attachment, SLDA) 成功回收
→ 最終 0 例

 兩款最新世代裝置早期療效相當；PASCAL 結構或與**較低 SLDA** 相關，提供 PMR 另一可靠選項



 Scan DOI

TEER #2 — 次發性 MR 的 GDMT 與 TEER 利用率

Bhasin V, Scherrer-Crosbie M, et al. *Cardiology* 2026 Jun 19.

 DOI: 10.1159/000551963

- 次發性 MR (secondary MR) + LVEF <50% , n=**508** ; 20% 死亡
- 3 個月僅 **53%** 達最佳化指引導向藥物治療 (Guideline-Directed Medical Therapy, GDMT)
- 高齡、慢性腎臟病 (CKD) 較少達標
- 僅 **9 例 (1.8%) **接受 TEER

 次發性 MR 死亡率高，但 GDMT 落實不足、TEER 嚴重未被使用 → 建立心衰竭—瓣
整合照護路徑



 Scan DOI

TEER #3 — TTVR 降低交感神經活性 (功能性 TR)

Nelles D, Nickenig G, et al. *Heart Vessels* 2026 Jun 19.

 DOI: [10.1007/s00380-026-02719-7](https://doi.org/10.1007/s00380-026-02719-7)

- 28 例功能性三尖瓣逆流 (Functional Tricuspid Regurgitation, FTR) $\geq$ III 接受經導管三尖瓣修復 (TTVR)
- microneurography 量測肌肉交感神經活性 (Muscle Sympathetic Nerve Activity, MSNA)
- 12 個月：TR、NYHA 顯著改善；**MSNA 發生率 192.8 $\rightarrow$ 72.6** ($p=0.01$)、頻率 167.8 $\rightarrow$ 93.4 ($p=0.001$)

 TTVR 改善**不僅來自血流動力學減壓，也有神經生理機轉** (樣本小，需驗證)



 Scan DOI



Honorable Mentions

其他值得一讀

其他值得一讀 (1/2)

研究	期刊	重點	DOI
HCM 心尖部動脈瘤與猝死	JACC Adv	n=510 ; <10 mm 0.2%/年 vs ≥40 mm 8.2%/年	10.1016/j.jacadv.2026.102919
PULSTA 經導管肺動脈瓣	Circ CV Interv	n=58 , 植入成功 98.3% ; 5 年免再介入 98.2%	10.1161/CIRCINTERVENTIONS.126.016616
急性 HF 停用 β-blocker	JACC Adv	短期停用或與死亡↑ (HR 2.30) , 證據確定性極低	10.1016/j.jacadv.2026.102929

其他值得一讀 (2/2)

研究	期刊	重點	DOI
MINOCA 新定義	<i>Eur Heart J</i>	從「梗塞」到「損傷」，重新框定為工作診斷	10.1093/eurheartj/ehag434
育齡女性風險認知落差	<i>JACC Adv</i>	56.8% 低估 CVD、58.3% 低估中風風險	10.1016/j.jacadv.2026.102862
經導管乳頭肌接合術	<i>EuroIntervention</i>	功能性 MR 的新介入概念 (編輯評論)	10.4244/EIJ-D-25-01353



Case Reports

JACC Case Rep / EuroIntervention

結構介入為主 × 5 例

Case #1 — 高風險 TAVR 的 IVUS 導引 Chimney Stenting

Nguyen PT, et al. JACC Case Rep 2026 Jun 18.

 DOI: [10.1016/j.jaccas.2026.108903](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.108903)

兩例不利冠狀動脈解剖之 TAVR。瓣膜釋放後血管攝影看似正常，但**血管內超音波 (IVUS)** 揭示冠狀動脈危險貼近／開口受壓 → chimney stenting 維持通暢，無併發症。

為什麼值得讀：主動式冠狀動脈保護的影像導引決策；**血管攝影可能低估**阻塞風險，IVUS 供互補價值



 Scan DOI

Case #2 — TAVI 後延遲性冠狀動脈阻塞致 MI

Krajewska N, Kołtowski Ł, et al. *Kardiol Pol* 2026 Jun 18.

  DOI: [10.33963/v.phj.113101](https://doi.org/10.33963/v.phj.113101)

TAVI 後延遲性冠狀動脈阻塞 (Delayed Coronary Obstruction, DCO) 導致心肌梗塞之影像報告。

為什麼值得讀：DCO 罕見但致命，可發生於術後數小時至數日；高風險解剖（低開口、窄 sinus、valve-in-valve）應預先規劃冠狀動脈保護



 Scan DOI

Case #3 — 漏斗胸致前負荷不足、竇性心搏過速

Alkhatib R, Ziada KM, et al. *JACC Case Rep* 2026 Jun 18.

 DOI: [10.1016/j.jaccas.2026.108778](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.108778)

65 歲女性長期心悸，高劑量 β -blocker 仍竇速。右心導管充填壓極低（RAP 1 mmHg），CMR 示嚴重漏斗胸（Haller index 8.1）。Ravitch 修補後心悸完全緩解。

為什麼值得讀：胸壁變形可致**前負荷不足**與代償性竇速，是**可逆**病因；不明原因竇速且充填壓低者應評估胸壁結構



 Scan DOI

Case #4 — 免疫檢查點抑制劑相關心包炎

Roy R, Addetia K, et al. *JACC Case Rep* 2026 Jun 18.

 [DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.108818](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.108818)

53 歲轉移性肺腺癌使用 pembrolizumab，反覆胸膜性胸痛。連續 CT 示進行性心包增厚，echo + CMR 確認心包發炎（無心肌炎）。NSAID + colchicine + 類固醇、停用 ICI 後緩解。

為什麼值得讀：免疫檢查點抑制劑 (ICI) 相關心包炎需高度警覺；多模態影像對診斷至關重要
(心臟腫瘤學必讀)



 Scan DOI

Case #5 — 序貫生物製劑後猛爆性嗜酸性球心肌炎

Lee J, Kim D, et al. JACC Case Rep 2026 Jun 18.

 [DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.108889](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.108889)

35 歲潰瘍性結腸炎，序貫生物製劑（vedolizumab）+ 類固醇減量後心因性休克，LVEF 10%、嗜酸性球 2,154/ μ L。切片確診嗜酸性球心肌炎，VA-ECMO + 類固醇支持；復發改用 mepolizumab 後恢復。

為什麼值得讀：生物製劑 + 類固醇減量者若嗜酸性球 $\uparrow$ + 急性 HF，警覺**嗜酸性球心肌炎**；
期切片指引升級至標靶治療



 Scan DOI



Take Home Message

1. 口服小分子 GLP-1 RA 來勢洶洶 — VISTA 36 週 -11.8%，已進 Phase 3（含 CV/腎臟結局）
2. 心血管死亡率種族落差未消弭 — 證據不足，需政策改革
3. AI-ECG 揪 HCM — 特異度 100%、提前 2.6 年；rule-in 工具
4. CKM 危險因子治療嚴重不足 — 高血壓/高血脂僅約半數受治療
5. FH 變異判讀有族群偏誤 — 非洲血統 VUS 即帶 MI 風險
6. 結構介入：PASCAL≈MitraClip G4；次發性 MR 的 GDMT/TEER 雙雙不足；TTVR 降交感
7. TAVI 細節：CIDs 血管併發症[↑]；術前 CTA 可靠；乳頭肌下移預測 MR 不改
善：DCO 須警覺

完整參考文獻 (1/2)

Top 5 Picks

1. Davies MJ, et al. Elecglipron (VISTA). [Lancet 2026;407:2503–2514](#).
2. Aroda VR, et al. Elecglipron (SOLSTICE). [Lancet 2026;407:2515–2527](#).
3. Arun AS, et al. Excess CV Mortality Among Black Americans. [JACC 2026](#).
4. Park J, et al. AI for HCM Detection From ECG. [JACC Adv 2026;5\(7\):102914](#).
5. Gong J, et al. Cardiometabolic Risk Factor Treatment in CKM Syndrome. [JACC 2026](#).
6. Winters AH, et al. Genome-First FH (African vs European). [Circulation 2026;153:1928–1939](#).

TAVI Section

7. Verma BR, et al. TAVR in Chronic Inflammatory Diseases. [Am J Cardiol 2026](#).
8. Kaya M, et al. Pre-TAVI CTA vs ICA. [J Med Imaging Radiat Oncol 2026](#).
9. Li X, et al. Papillary Muscles and MR After TAVR. [Catheter Cardiovasc Interv 2026](#).

完整參考文獻 (2/2)

TEER Section

10. Enta Y, et al. PASCAL vs MitraClip G4 (OCEAN-Mitral). *Catheter Cardiovasc Interv* 2026.
11. Bhasin V, et al. GDMT and TEER in Secondary MR. *Cardiology* 2026.
12. Nelles D, et al. Autonomic Modulation After TTVR. *Heart Vessels* 2026.

Honorable Mentions

13. Rowin EJ, et al. HCM With Apical Aneurysms. *JACC Adv* 2026;5(7):102919.
14. Lee SY, et al. PULSTA Pulmonary Valve. *Circ Cardiovasc Interv* 2026.
15. Alaeiikhchi N, et al. Beta-Blocker Discontinuation in Acute HF. *JACC Adv* 2026;5(7):102929.
16. Bucciarelli-Ducci C, et al. New definition of MINOCA. *Eur Heart J* 2026.
17. Stanislas KA, et al. Risk Discordance in Women. *JACC Adv* 2026;5(7):102862.
18. Tekieli L, et al. Transcatheter approximation of papillary muscles. *EuroIntervention* 2026;22(12):e712–e715.

Case Reports

- 19–23. Nguyen PT (108903) · Krajewska N (v.phj.113101) · Alkhatib R (108778) · Roy R (108818) · Lee J (108889). *JACC Case Rep / Kardiol Pol* 2026.

縮寫對照表 (1/2)

縮寫	全名 (英文)	中文
GLP-1 RA	Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonist	升糖素類似胜肽-1 受體促效劑
T2D	Type 2 Diabetes	第二型糖尿病
HbA1c	Glycated Hemoglobin	糖化血色素
HCM	Hypertrophic Cardiomyopathy	肥厚型心肌病
ECG	Electrocardiogram	心電圖
CMR	Cardiac Magnetic Resonance Imaging	心臟磁共振影
CKM	Cardiovascular-Kidney-Metabolic syndrome	心—腎—代謝症候群
CKD	Chronic Kidney Disease	慢性腎臟病
FH	Familial Hypercholesterolemia	家族性高膽固醇血症
LDL-C	Low-Density Lipoprotein Cholesterol	低密度脂蛋白膽固醇
VUS	Variant of Unknown Significance	意義未明變異
MI	Myocardial Infarction	心肌梗塞
TAVR / TAVI	Transcatheter Aortic Valve Replacement / Implantation	經導管主動脈瓣置換術
CIDs	Chronic Inflammatory systemic Diseases	慢性發炎性全身疾病
CTA	CT Angiography	電腦斷層血管攝影
ICA	Invasive Coronary Angiography	侵入性冠狀動脈攝影
CAD	Coronary Artery Disease	冠狀動脈疾病

縮寫對照表 (2/2)

縮寫	全名 (英文)	中文
MSCT	Multi-Slice Computed Tomography	多排電腦斷層
MR	Mitral Regurgitation	二尖瓣逆流
PMR	Primary Mitral Regurgitation	原發性二尖瓣逆流
PM	Papillary Muscle	乳頭肌
M-TEER / TEER	(Mitral) Transcatheter Edge-to-Edge Repair	(二尖瓣) 經導管緣對緣修復
SLDA	Single Leaflet Device Attachment	單葉裝置附著
GDMT	Guideline-Directed Medical Therapy	指引導向藥物治療
LVEF	Left Ventricular Ejection Fraction	左心室射出分數
FTR	Functional Tricuspid Regurgitation	功能性三尖瓣逆流
TTVR	Transcatheter Tricuspid Valve Repair/Replacement	經導管三尖瓣修復／置換
TR	Tricuspid Regurgitation	三尖瓣逆流
MSNA	Muscle Sympathetic Nerve Activity	肌肉交感神經活性
SCD	Sudden Cardiac Death	心因性猝死
IVUS	Intravascular Ultrasound	血管內超音波
DCO	Delayed Coronary Obstruction	延遲性冠狀動脈阻塞
ICI	Immune Checkpoint Inhibitor	免疫檢查點抑制劑
VA-ECMO	Veno-Arterial Extracorporeal Membrane Oxygenation	靜脈—動脈體外膜氧合
MINOCA	MI with Non-Obstructive Coronary Arteries	非阻塞性冠狀動脈心肌梗塞

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

心臟內科 | 結構性心臟病介入

本文件為讀書會共筆之教學整理，
僅供醫療專業同仁臨床教學交流參考。